

CAPÍTULO 9.16

Patologías Genéticas de la Hemostasia Primaria

PERFIL EUNACOM 1.07.2.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfermedad de Von Willebrand (EvW)

Definición

- Hemoglobinopatía genética más frecuente de la hemostasia primaria
- Déficit o disfunción del **factor de Von Willebrand (FvW)** → falla en la adhesión plaquetaria y en el transporte del factor VIII
- Autosómica** (afecta ambos sexos — ≠ **hemofilia** que es ligada al X → solo hombres)

Clínica

- Alteración de hemostasia **primaria**: petequias, equimosis, sangrado mucoso
- Formas graves → puede parecer hemofilia (hematomas profundos, ↑ TTPK por ↓ factor VIII)
- Frecuentemente: **epistaxis** recurrente, hipermenorrea, alveolorrhagia

Laboratorio

- Hemograma: normal** (no es trombocitopenia, es disfunción plaquetaria)
- Tiempo de sangría ↑
- TTPK puede estar ↑ (en tipos severos)
- Pruebas de función plaquetaria / agregación** → alteradas
- Niveles de FvW** (↓ en tipo 1 y 3; normal en tipo 2 — el funcional es lo que falla)

Tipos

TABLA 9.16.1: TIPO VS FVW			
TIPO	FVW	CLÍNICA	FRECUENCIA
Tipo 1	↓ cantidad (leve-moderado)	Leve	Más frecuente (~70%)
Tipo 2	Normal o ↓ pero disfuncional	Moderada	Variable
Tipo 3	Ausente	Severa	Raro
Tipo 2B	↑ afinidad por plaquetas → ↓ FvW en plasma	Trombocitopenia	Raro

Tratamiento

TABLA 9.16.2: SEVERIDAD VS TRATAMIENTO	
SEVERIDAD	TRATAMIENTO
Leve	Observar
Moderado	Desmopresina (DDAVP) → libera FvW de las células endoteliales

| Grave (tipo 3, hemorragia mayor) | **FvW concentrado EV** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 20 años consulta por menorragias abundantes desde la menarquia que duran 8 días, y antecedentes de epistaxis frecuentes y sangrado prolongado tras extracción dental. Antecedente materno de sangrado fácil. Laboratorio: Hemograma y recuento de plaquetas normales (220.000/mm³), TP normal, TTPA levemente prolongado (42 seg, control 30s), Tiempo de sangría / Tiempo de oclusión PFA-100 marcadamente prolongado."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Enfermedad de Von Willebrand (EvW): la coagulopatía hereditaria más frecuente (autosómica dominante). El Factor von Willebrand permite la adhesión plaquetaria al subendotelio y transporta/estabiliza al Factor VIII en plasma (de ahí el TTPA prolongado). Tratamiento de episodios hemorrágicos: Desmopresina (DDAVP nasal o EV, libera FvW endógeno desde los cuerpos de Weibel-Palade) en EvW tipo 1, o concentrados de FvW/Factor VIII en casos severos o tipo 2/3. Ácido tranexámico (antifibrinolítico) como coadyuvante.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La enfermedad de von Willebrand es la patología genética de hemostasia primaria más frecuente
- Es autosómica (afecta ambos sexos), a diferencia de la hemofilia que es ligada al X
- Hemograma normal (disfunción plaquetaria, no trombocitopenia). Excepción: tipo 2B puede tener trombocitopenia
- Puede alargar el TTPA porque el factor de vW se une al factor VIII
- Diagnóstico: pruebas de agregación/función plaquetaria y niveles de von Willebrand
- Tratamiento según severidad: observar, desmopresina o factor de vW endovenoso
- No confundir con PTI (trombocitopenia aislada) ni con hemofilia (ligada al X, más grave)
- Otras: enfermedad de Glanzmann y Bernard-Soulier (más raras)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍAS GENÉTICAS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA)**PREGUNTA 1**

Mujer de 25 años con historia de petequias recurrentes desde la infancia, gingivorragia frecuente y menstruaciones abundantes. Hemograma con plaquetas normales, tiempo de sangría alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** PTI crónica
- B)** Hemofilia A
- C)** Enfermedad de von Willebrand
- D)** Enfermedad de Bernard-Soulier
- E)** CID

PREGUNTA 2

¿Por qué la enfermedad de von Willebrand puede alargar el TTPA en casos severos?

- A)** Porque produce trombocitopenia severa
- B)** Porque inhibe directamente el factor XII
- C)** Porque el factor de vW se une al factor VIII; al bajar el vW, baja el factor VIII
- D)** Porque activa la fibrinólisis
- E)** Porque produce anticuerpos contra factores de coagulación

PREGUNTA 3

Paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3 (severa) con hemorragia activa. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?

- A)** Desmopresina
- B)** Corticoides endovenosos
- C)** Factor de von Willebrand endovenoso
- D)** Transfusión de plaquetas
- E)** Esplenectomía

RESUMEN: PATOLOGÍAS GENÉTICAS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA

Esta clase cubre las patologías genéticas de la hemostasia primaria, con énfasis en la enfermedad de von Willebrand (EvW) como la más frecuente. Estas patologías se caracterizan por petequias, equimosis, sangrados de mucosas y tiempo de sangría alargado. La EvW es autosómica (afecta ambos sexos), a diferencia de la hemofilia que es ligada al X. La clínica es de hemostasia primaria desde leve hasta severa. En los casos graves puede alargar el TTPA porque el factor de von Willebrand se une al factor VIII. El hemograma suele ser normal (disfunción plaquetaria, no trombocitopenia), excepto el tipo 2B que puede tener trombocitopenia. El diagnóstico se hace con pruebas de agregación/función plaquetaria y niveles de von Willebrand. El tratamiento va desde observación hasta desmopresina (libera factor de vW) y en casos graves, factor de von Willebrand endovenoso. Se mencionan otras patologías genéticas más raras: enfermedad de Glanzmann y enfermedad de Bernard-Soulier.